

УДК:616-006.484:615-036.8

С.Б. Бердаuletов, Ш.У. Аязбаев, Р.Р. Шарыгин, К.К. Саргожаев

Мангистауская областная больница, г. Актау

Оценка эффекта терапии анапластических глиом головного мозга

Аннотация. Адекватная оценка эффекта лечения анапластических глиом головного мозга (АГГМ) актуальна и имеет высокую практическую ценность.

Цель исследования – изучение диагностической эффективности компьютерной и магнитно-резонансной томографии и обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Материалы исследования. выполнена КТ, МРТ, диффузно-взвешенная МРТ. Обследовано 19 больных с анапластической астроцитомой (13/68%), глиобластомой (6/31%).

Диагностические возможности МРТ без ДКУ и особенно КТ в обнаружении продолженного роста анапластических глиом головного мозга в ранний период после удаления опухоли, лучевой терапии крайне низкие и непригодны для указанной цели.

Следует ожидать более позитивных результатов от применения протонной МР-спектроскопии.

Ключевые слова: анапластическая глиома головного мозга: диагностика.

Актуальность

Адекватная оценка эффекта лечения анапластических глиом головного мозга (АГГМ) актуальна и имеет высокую практическую ценность.

Смертность от анапластических глиом головного мозга сохраняется на очень высоких показателях и обусловлена многими факторами, среди которых большую роль играют нерадикальное удаление этих опухолей и несвоевременное обнаружение рецидивов и продолженного роста новообразований. Дело дошло до появления гибридных операционных блоков клиник, оснащенных магнитно-резонансными томографами с высокой напряженностью магнитного поля.

Продолженный рост и рецидив анапластических глиом головного мозга диагностируется в относительно поздние сроки после операции и лучевой терапии. Поэтому практическую ценность в уменьшении смертности от анапластических глиом головного мозга имеет обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Цель исследования

- изучение диагностической эффективности компьютерной и магнитно-резонансной томографии и обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Материалы исследования

КТ выполнена на томографе HiSpeedNX/1 GE, МРТ - на МР-системе AchievaPhilips(1,5T) с динамическим контрастным усилением (ДКУ), диффузно-взвешенная МРТ с фактором взвешенности 0; 500; 1000с/мм².
Обследовано 19

больных с анапластической астроцитомой (13/68%), глиобластомой (6/31%). Возраст больных составил от 37 до 62 лет. Мужчин было 11 (57%), женщин - 8 (42%). КТ выполнена всем больным, из них 17 пациентам (57%) - динамическая КТ. Магнитно-резонансная томография использована в 13 (68%) случаях, из которых в двух случаях - без ДКУ. Хирургическая операция по удалению опухоли головного мозга была выполнена 15 (78%) больным с АГГМ и в последующем проведена лучевая терапия, но 4 (21%) больным после операции не была проведена лучевая терапия. КТ и МРТ выполнялись в ранние сроки после удаления АГГМ и завершения лучевой терапии.

Результаты

Ни в одном случае КТ и МРТ в ранние сроки после удаления опухоли не удалось с уверенностью высказать конкретного мнения в отношении наличия или отсутствия остаточной опухоли. КТ-диагностика продолженного роста в течение первых трех месяцев оказалась почти непреодолимой диагностической задачей. Оказалось возможным установить возобновление опухолевого роста у 16 (84%) больных, продолженного роста и рецидива - только в течение последующих 6-12 месяцев в основном благодаря МРТ с ДКУ.

Высказать конкретное мнение о продолженном росте АГГМ в ранний период после операции и лучевой терапии оказалось возможным только после проведения МРТ с ДКУ в 2-х случаях, т.к. диагностические возможности диффузно-взвешенной МРТ весьма скромны.

Выводы

Диагностические возможности МРТ без ДКУ и, особенно, КТ в обнаружении продолженного роста анапластических глиом головного мозга в ранний период после удаления опухоли, лучевой терапии крайне низкие и непригодны для указанной цели в дифференциации так называемых «псевдоответов на терапию», «псевдо прогрессирования АГГМ» при лучевой терапии, «контаминационного» опухолевого отека головного мозга. Диагностические возможности МРТ с ДКУ, DW: (b= 0;500; 1000) в течение первых трех месяцев после удаления АГГМ и лучевой терапии также ограничены.

Следует ожидать более позитивных результатов от применения протонной МР-спектроскопии.

Тұжырым

С.Б.Бердавлетова, Ш.У.Шарыгин, К.К.Саргожаев
Манғыстау облысының ауруханасы, Ақтау қаласы

Бас миының анапластикалық глиом шипасының
нәтижесінің адекваттық сарапшылығы көкейкесті

Бас миының анапластикалық глиом шипасының
нәтижесінің адекваттық сарапшылығы көкейкесті
және биік практикалық бағасы.

Зерттеу мақсаты – сәулелі терапиясы және ерте
кездегі хирургиялық емнен кейінгі диагностикалау
тиімділігі компьютерной және магнит-резонанстық
томографияда өсудің артуы табылды. Зерттеу
материалы. КТ орындау, МРТ, диффузно-взвешенная
МРТ. Анапластикалық астроцитомда 19 науқастың
зерттеуі (13/68%) глиобластомой (6/31%). Обырды
ерте алынып тастаған кезеннен кейінгі диагностика
мүмкіндіктері МРТ ДКУ-сыз жасалған, әсіресе КТ-дан
бас миының анапластикалық глиомасының өсуін көруге
болады. Протонды МР-спектроскопия қолданғанда
көбірек тиімді жағымды нәтиже куту тиіс.

Түйінді сөздер: бас миының анапластикалық глио-
масы: диагностика.

Summary

S.B.Berdavletov, Sh.U.Ayazbaev, R.R.Sharygin,
K.K.Sargozhaev

Mangistau regional hospital in Aktau

Adequate assessment of the effect of treatment of ana-
plastic gliomas of the brain relevant

Adequate assessment of the effect of treatment of
anaplastic gliomas of the brain (AGGM) relevant and has
high practical value.

The purpose of research - the study of the diagnostic
efficiency of computer and magnetic resonance imaging
and detection of continued growth in the early period after
surgery and radiotherapy.

Materials research. CT scan, MRI, diffusion-weighted
MRI. The study involved 19 patients with anaplastic
astrocytoma (13/68%), glioblastoma (6/31%).

The diagnostic capabilities of MRI without order, and
especially CT in the detection of the continued growth of
anaplastic gliomas of the brain in the early period after removal
of the tumor, radiation therapy is extremely low and are not
suitable for this purpose.

We should expect more positive results from the use of
proton MR spectroscopy.

Keywords: anaplastic glioma brain: diagnosis.